



Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nén giải phóng có kiểm soát có chứa:

Hoạt chất: Gliclazid.....30 mg

Tá dược: mannitol, acid stearic, sáp camauba, dinatri phosphat khan, hypromellose type K4 MCR, magnesi stearat, silic dioxid keo khan, hypromellose type 5 cps, macrogol 4000, lalc, titan dioxid.

DẠNG BẢO CHẾ

Viên nén giải phóng có kiểm soát.

Mô tả dạng bào chế: Viên nén màu trắng, hình oval.

CHỈ ĐỊNH

Bái tháo đường không phụ thuộc insulin (đái tháo đường tuýp 2) ở người lớn, khi chế độ dinh dưỡng, thể dục và giảm cân đơn thuần không đủ để kiểm soát đường huyết.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Liều hàng ngày có thể thay đổi từ 1 đến 4 viên mỗi ngày, tương đương từ 30 tới 120 mg, dùng đường uống một lần lúc ăn sáng.

Nên nuốt cả viên thuốc.

Nếu quên uống một liều, không được tăng liều ở lần uống tiếp sau đó.

Tương tự như ở các thuốc hạ đường huyết khác, liều dùng cần được điều chỉnh theo mức đáp ứng chuyển hóa của từng bệnh nhân cụ thể (mức đường huyết, HbA1c).

Liều khởi đầu:

Liều khởi đầu được khuyến cáo là 30mg mỗi ngày.

Nếu mức đường huyết được kiểm soát hiệu quả, mức liều này có thể được dùng để điều trị duy trì.

Nếu mức đường huyết không được kiểm soát đầy đủ, cần tăng liều tới 60, 90 hoặc 120mg mỗi ngày ở bước điều trị kế tiếp. Khoảng thời gian giữa mỗi lần tăng liều tối thiểu là 1 tháng trừ trường hợp bệnh nhân có mức đường huyết không giảm sau hai tuần điều trị. Trong trường hợp đó, liều dùng có thể tăng lên ở thời điểm cuối của tuần điều trị thứ hai.

Liều tối đa khuyến cáo hàng ngày là 120 mg.

Chuyển từ dùng viên nén sang dùng viên giải phóng có kiểm soát:

1 viên gliclazid 80mg có thể tương đương 1 viên gliclazid 30mg giải phóng có kiểm soát. Do đó việc chuyển đổi sử dụng có thể được tiến hành miễn là kiểm soát thận trọng đường huyết.

Chuyển đổi từ các thuốc chống đái tháo đường dùng đường uống khác sang viên giải phóng có kiểm soát:

Gliclazid giải phóng có kiểm soát có thể được dùng để thay thế các thuốc chống đái tháo đường dùng đường uống khác.

Liều và thời gian bán thải của thuốc chống đái tháo đường dùng trước đó cần được xem xét khi chuyển sang dùng gliclazid giải phóng có kiểm soát.

Nhiệm vụ chung không cần giai đoạn chuyển tiếp khi chuyển thuốc. Nên khởi đầu dùng với liều 30 mg và nên điều chỉnh liều để phù hợp với đáp ứng đường huyết của bệnh nhân như mô tả ở trên.

Khi chuyển từ một thuốc hạ đường huyết nhóm sulfonyl ure với thời gian bán thải kéo dài, giai đoạn không điều trị thuốc trong vài ngày có thể là cần thiết để tránh các tác dụng cộng thêm của hai thuốc, mà có thể gây ra hạ đường huyết. Quá trình mô tả để khởi đầu điều trị cũng nên được áp dụng khi chuyển sang điều trị với gliclazid giải phóng có kiểm soát, ví dụ liều khởi đầu 30 mg/ngày, sau đó là sự tăng dần từng bước liều dùng, tùy theo đáp ứng chuyển hóa của bệnh nhân.

Phối hợp với các thuốc hạ đường huyết khác:

Gliclazid có thể được dùng phối hợp với biguanid, các thuốc ức chế alpha-glucosidase hay insulin.

Ở những bệnh nhân không đủ kiểm soát bệnh với gliclazid, có thể phối hợp với insulin nhưng phải theo dõi chặt chẽ.

Các đối tượng đặc biệt

Người cao tuổi: Gliclazid giải phóng có kiểm soát nên được kê với liều tương tự liều khuyến cáo cho bệnh nhân dưới 65 tuổi.

Bệnh nhân suy thận: Ở bệnh nhân suy thận mức độ nhẹ tới vừa, có thể dùng liều tương tự như ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường, kèm theo chế độ theo dõi chặt chẽ. Những dữ liệu này đã được chứng minh trên lâm sàng.

Bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết:

- Dinh dưỡng kém hoặc suy dinh dưỡng,
- Rối loạn nội tiết mức độ nặng hoặc kém bù (suy tuyến yên, suy giáp, giảm ACTH)
- Dùng liệu pháp corticosteroid kéo dài và/hoặc liều cao,
- Bệnh mạch máu nặng (bệnh mạch vành nặng, suy động mạch cảnh nặng, bệnh mạch máu lan tỏa).

Khuyến cáo liều tối thiểu khởi đầu mỗi ngày là 30mg.

Trẻ em: Các dữ liệu an toàn và hiệu quả của gliclazid giải phóng có kiểm soát ở trẻ em và trẻ vị thành niên chưa được thiết lập. Không có dữ liệu nào về việc dùng thuốc này trên trẻ em.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với gliclazid hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc, các thuốc khác thuộc nhóm sulfonylurea, các sulfonamide,

Đái tháo đường phụ thuộc insulin (tuýp 1),

Hôn mê hay tiền hôn mê do đái tháo đường; nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Suy gan nặng, suy thận nặng; trong những trường hợp này dễ nghĩ sử dụng insulin.

Điều trị bằng miconazole.

Cho con bú.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Hạ đường huyết: Điều trị bằng thuốc này chỉ được kê khi bệnh nhân thật sự có chế độ ăn uống đều đặn (bao gồm bữa sáng). Việc ăn một lượng carbon hydrate đều đặn là rất quan trọng do sự tăng nguy cơ hạ đường huyết khi ăn muộn, nếu lượng thức ăn đưa vào cơ thể không đủ hoặc nếu thức ăn có hàm lượng carbon hydrate thấp.

Sự hạ đường huyết hay xảy ra khi chế độ ăn có mức calo thấp, sau khi luyện tập kéo dài hoặc đòi hỏi gắng sức, uống rượu hoặc nếu kết hợp sử dụng các thuốc hạ đường huyết khác.

Sự hạ đường huyết có thể xảy ra sau khi dùng các thuốc nhóm sulfonylure. Một số trường hợp có thể trở nên nghiêm trọng và kéo dài. Khi đó cần nhập viện và nạp đường liên tục trong vài ngày.

Cần lựa chọn cẩn thận đối tượng bệnh nhân, liều dùng và hướng dẫn bệnh nhân một cách rõ ràng nhằm giảm nguy cơ hạ đường huyết. Các yếu tố làm tăng nguy cơ hạ đường huyết:

- Bệnh nhân từ chối hoặc không có khả năng hợp tác (đặc biệt ở đối tượng người cao tuổi).
- Suy dinh dưỡng, thời gian ăn uống thất thường, bỏ bữa, các giai đoạn nhịn ăn hoặc thay đổi chế độ ăn kiêng.
- Sự mất cân bằng giữa chế độ luyện tập thể lực và lượng carbon hydrate nạp vào.
- Suy thận.
- Suy gan nặng.
- Quá liều gliclazid.
- Rối loạn nội tiết: rối loạn tuyến giáp, suy giảm tuyến yên và suy thượng thận.
- Sử dụng đồng thời một số loại thuốc khác.

Suy thận và suy gan: các đặc tính dược động học và/hoặc dược lực học của gliclazid có thể biến đổi ở bệnh nhân suy gan hoặc suy thận nặng. Sự hạ đường huyết ở những bệnh nhân này có thể kéo dài, do đó cần kiểm soát bệnh nhân chặt chẽ.

Thông tin bệnh nhân: Nguy cơ hạ đường huyết, cùng với những triệu chứng, việc điều trị, và những điều kiện có thể dẫn đến sự phát triển nguy cơ này cần được giải thích cho bệnh nhân và người nhà được biết.

Bệnh nhân cũng cần được thông báo về tầm quan trọng của việc tuân thủ lời khuyên về chế độ ăn, về việc luyện tập thường xuyên và việc kiểm soát định kỳ mức đường huyết.

Kiểm soát đường huyết kém: việc kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đang được điều trị đái tháo đường có thể bị ảnh hưởng bởi một trong những yếu tố sau: dùng các chế phẩm có chứa St. John's Wort (*Hypericum perforatum*), sốt, chấn thương, nhiễm khuẩn hoặc can thiệp phẫu thuật. Trong một số trường hợp, có thể cần sử dụng insulin.

Hiệu quả giảm đường huyết của bất cứ thuốc điều trị đái tháo đường đường uống nào, bao gồm gliclazid, bị suy giảm đi theo thời gian ở một số bệnh nhân: điều này có thể do sự tiến triển mức độ nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường, hoặc giảm đáp ứng với điều trị. Hiện tượng này được biết đến như là thất bại thứ phát, khác với thất bại nguyên phát, khi hoạt chất không có hiệu quả khi mới điều trị. Việc điều chỉnh liều một cách thích hợp và tuân thủ chế độ ăn uống cần được xem xét trước khi phân loại bệnh nhân vào nhóm thất bại thứ phát.

Rối loạn đường huyết: Các rối loạn về đường huyết bao gồm hạ đường huyết và tăng đường huyết đã được báo cáo, ở các bệnh nhân đái tháo đường đang được điều trị đồng thời bằng các fluoroquinolone, đặc biệt là người cao tuổi. Trên thực tế, khuyến cáo theo dõi đường huyết cẩn thận ở tất cả các bệnh nhân dùng đồng thời gliclazid và một fluoroquinolone.

Xét nghiệm: Việc đo mức hemoglobin glycat (hay nồng độ đường huyết tĩnh mạch lúc đói) được khuyến cáo nhằm đánh giá mức đường huyết. Việc tự đo mức đường huyết cũng có thể hữu hiệu.

Việc điều trị bệnh nhân thiếu G6PD với các thuốc nhómsulfonylure có thể dẫn tới thiếu máu tan huyết. Do gliclazid thuộc nhóm sulfonylure, cần thận trọng ở bệnh nhân thiếu G6PD và có thể cần nhắc sử dụng thuốc thay thế không thuộc nhóm sulfonylure.

Bệnh nhân rối loạn chuyển hóa porphyrin: Các trường hợp rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp đã được mô tả với một số thuốc sulfonylurea, ở các bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Tá dược mannitol: Có thể gây tác dụng nhuận tràng nhẹ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thời kỳ mang thai: Không có bằng chứng nghiên cứu nào về việc sử dụng gliclazid trong quá trình mang thai ở người, mặc dù có một số dữ liệu đối với các thuốc khác thuộc nhóm sulfonylure. Nghiên cứu trên động vật cho thấy gliclazid không gây quái thai.

Điều trị đái tháo đường cần được tiến hành trước thời điểm mang thai nhằm làm giảm nguy cơ gây dị tật bẩm sinh liên quan đến không kiểm soát được bệnh đái tháo đường.

Các thuốc hạ đường huyết dùng đường uống không thích hợp, insulin là lựa chọn hàng đầu cho điều trị đái tháo đường trong quá trình mang thai. Liều phàn hạ đường huyết đường uống được khuyến cáo là nên chuyển sang sử dụng insulin trước khi có thai, hoặc ngay khi phát hiện mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Không rõ thuốc có phân bố vào sữa hay không. Tuy nhiên, hạ đường huyết ở trẻ nhỏ có khả năng xảy ra, vì vậy chống chỉ định dùng gliclazid trong thời kỳ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa phải hiện gliclazid có ảnh hưởng nào lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được cảnh báo trước những triệu chứng hạ đường huyết và thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc, đặc biệt ở giai đoạn đầu điều trị.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỊ CỦA THUỐC

1) Các thuốc sau có khả năng làm tăng nguy cơ hạ đường huyết:**Phối hợp là chống chỉ định**

- Micouazole (dùng đường toàn thân, gel bôi niêm mạc miệng): tăng tác dụng hạ đường huyết với khả năng gây ra triệu chứng giảm đường huyết, thậm chí hôn mê.

Phối hợp không được khuyến dùng

- Phenylbutazone (đường dùng toàn thân): tăng tác dụng hạ đường huyết của sulfonylurea (thay thế với protein huyết tương và/hoặc giảm sự thải trừ của chúng).

Việc lựa chọn một thuốc chống viêm khác sẽ thích hợp hơn, hoặc cảnh báo bệnh nhân và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiểm soát. Nếu cần thiết, điều chỉnh liều trong và sau quá trình điều trị bằng thuốc chống viêm.

- Rượu: làm tăng phản ứng giảm đường huyết (do ức chế các phản ứng bù), điều này có thể dẫn tới tình trạng hôn mê giảm đường huyết.

Tránh uống rượu hoặc các thuốc có chứa cồn.

Phối hợp cần thận trọng: Do nguy cơ làm giảm mức đường huyết và do đó, trong một số trường hợp, hạ đường huyết có thể xảy ra khi một trong số các thuốc sau được sử dụng:

Các thuốc chống đái tháo đường khác (insulin, acarbose, metformin, thiazolidinedione, thuốc ức chế dipeptidyl peptidase-4, chất đối kháng thụ thể GLP-1), thuốc chẹn beta, fluconazole, thuốc ức chế men chuyển angiotensin (captopril, enalapril), chất đối kháng thụ thể H2, các thuốc IMAO, các thuốc nhóm sulfonamide, clarithromycin và thuốc chống viêm non-steroid.

2) Các thuốc sau có thể gây tăng mức đường huyết

Phối hợp không được khuyến dùng

- Danazol: tác động gây đái tháo đường của danazol.

Nếu không thể tránh sử dụng chất này, cần cảnh báo bệnh nhân và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát nước tiểu và đường huyết. Việc điều chỉnh liều thuốc điều trị đái tháo đường có thể cần thiết trong và sau khi điều trị với danazol.

Phối hợp cần thận trọng

- Chlorpromazine (thuốc an thần): liều cao (>100 mg chlorpromazine mỗi ngày) làm tăng mức đường huyết (giảm giải phóng insulin)

Cần cảnh báo bệnh nhân tầm quan trọng của việc kiểm soát đường huyết. Việc điều chỉnh liều thuốc điều trị đái tháo đường có thể cần thiết trong và sau khi điều trị bằng thuốc an thần.

- Glucocorticoid (dùng đường toàn thân và dùng tại chỗ: trong khớp, hấp thu qua da và qua đường trực tràng) và tetracosactrin: làm tăng nồng độ đường huyết kèm khả năng nhiễm toan ceton (giảm sử dụng nạc carbon hydrate do các thuốc glucocorticoid).

Cần cảnh báo bệnh nhân tầm quan trọng của việc kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở thời điểm khởi đầu điều trị. Việc điều chỉnh liều thuốc điều trị đái tháo đường có thể cần thiết trong và sau khi điều trị bằng thuốc glucocorticoid.

- Ritodrine, salbutamol, terbutaline (dùng đường tĩnh mạch):

Làm tăng mức đường huyết do tác động đối kháng beta-2

Cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát đường huyết. Nếu cần, chuyển sang dùng insulin.

- Các chế phẩm có chứa Saint John's Wort (*Hypericum perforatum*):

Nồng độ gliclazid bị giảm bởi Saint John's Wort (*Hypericum perforatum*). Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi đường huyết.

3) Các thuốc sau có thể gây rối loạn đường huyết

Phối hợp cần thận trọng

- Fluoroquinolone: khi sử dụng đồng thời gliclazid và fluoroquinolon, bệnh nhân nên được cảnh báo về nguy cơ rối loạn đường huyết và tầm quan trọng của việc kiểm soát đường huyết.

Phối hợp cần cần nhắc

- Liệu pháp chống đông (warfarin...): Các thuốc nhóm sulfonylure có thể dẫn tới nguy cơ chống đông máu trong quá trình dùng đồng thời. Việc điều chỉnh thuốc chống đông có thể cần thiết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Dựa trên những dữ liệu về gliclazid, những tác dụng không mong muốn sau đã được ghi nhận.

Hạ đường huyết: Tương tự các thuốc nhóm sulfonylure, việc điều trị với gliclazid có thể gây hạ đường huyết, nếu thời gian ăn uống không điều độ và đặc biệt, nếu bỏ bữa ăn. Các triệu chứng của hạ đường huyết có thể xảy ra là: đau đầu, đói dữ dội, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, lo lắng, hưng hững, kém tập trung, giảm nhận thức và phản ứng chậm, suy nhược, bối rối, rối loạn thị giác và rối loạn khả năng nói, chứng mất ngôn ngữ, run, liệt nhẹ, rối loạn cảm giác, chóng mặt, cảm giác bất lực, mất khả năng tự điều chỉnh, mê sảng, co giật, thờ nóng, nhịp tim chậm, buồn ngủ và mất ý thức, có khả năng dẫn đến hôn mê và tử vong.

Ngoài ra, có thể quan sát thấy các dấu hiệu của điều hòa ngược hệ giao cảm bao gồm: đỏ mắt, da lạnh, lo lắng, nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, đánh trống ngực, đau thắt ngực và loạn nhịp tim.

Thông thường, các triệu chứng sẽ mất đi sau khi nạp carbon hydrate (đường). Tuy nhiên, các việc ngăn ngừa không có tác dụng gì. Các nghiên cứu với các thuốc khác thuộc nhóm sulfonylure cho thấy giảm đường huyết có thể xảy ra ngay cả khi các biện pháp có bằng chứng hiệu quả đã được tiến hành.

Nếu cơn hạ đường huyết nặng hoặc kéo dài, thậm chí đã được kiểm soát tạm thời bằng cách nạp đường, việc điều trị cấp cứu hoặc nhập viện ngay lập tức vẫn được yêu cầu.

Rối loạn tiêu hóa, bao gồm triệu chứng đau bụng, buồn nôn, khó tiêu, tiêu chảy và táo bón đã được báo cáo: nếu có những triệu chứng này xảy ra, chúng có thể được phòng tránh hoặc giảm thiểu ảnh hưởng nếu gliclazid được dùng lúc ăn sáng.

Những tác dụng không mong muốn sau đây hiếm gặp hơn:

- Rối loạn về da và mô dưới da: ban da, ngứa, nổi mề đay, phù mạch, ban đỏ, ban sẩn trên da, phỏng rộp (như hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc).
- Rối loạn về máu và hệ bạch huyết: Thay đổi về huyết học hiếm xảy ra, có thể bao gồm thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu hạt. Những triệu chứng này nhìn chung có thể hồi phục khi dùng thuốc.
- Rối loạn gan - mật: tăng nồng độ enzyme gan (AST, ALT, alkaline phosphatase), viêm gan (báo cáo riêng lẻ). Dừng thuốc nếu xuất hiện triệu chứng vàng da ứ mật.

Những triệu chứng này thường mất đi khi dùng điều trị.

- Rối loạn về mắt: Rối loạn thị giác thoáng qua có thể xảy ra đặc biệt khi khởi đầu điều trị, do sự thay đổi về nồng độ đường huyết.

Tác dụng không mong muốn thuộc phân nhóm thuốc: Tương tự các thuốc khác thuộc nhóm sulfonylure, những biến cố bất lợi sau đây đã được ghi nhận: các trường hợp giảm hồng cầu, mất bạch cầu hạt, thiếu máu tan huyết, giảm toàn thể huyết cầu, viêm mạch dị ứng, hạ natri máu, tăng men gan và thậm chí suy chức năng gan (ví dụ ứ mật và vàng da) và viêm gan - triệu chứng này có thể thoái lui khi dùng thuốc sulfonylure hoặc dẫn tới suy gan đe dọa đến tính mạng trong một vài trường hợp đặc biệt.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Việc dùng quá liều thuốc nhóm sulfonylure có thể gây hạ đường huyết.

Các triệu chứng nhẹ của hạ đường huyết, không kèm mất ý thức hoặc các dấu hiệu thần kinh, cần được điều chỉnh bằng cách nạp carbon hydrat, điều chỉnh liều và đặc biệt với insulin đã được quan sát thấy sau khi có kích thích gây ra bởi bữa ăn hoặc glucose.

Phản ứng hạ đường huyết nghiêm trọng, kèm hôn mê, co giật hoặc những rối loạn thần kinh khác có thể xảy ra và cần được xử trí như trường hợp cấp cứu, cần đưa bệnh nhân tới bệnh viện ngay lập tức.

Nếu tình trạng hôn mê hạ đường huyết được phát hiện hoặc nghi ngờ xảy ra, bệnh nhân cần được tiêm tĩnh mạch nhanh 50 ml dung dịch glucose nồng độ cao (20% tới 30%). Sau đó nên truyền liên tục dung dịch glucose nồng độ loãng hơn (10%) với tốc độ duy trì mức đường huyết trên 1 g/l. Bệnh nhân nên được kiểm soát chặt chẽ và, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân sau thời điểm này, bác sĩ sẽ quyết định liệu có cần tiếp tục kiểm soát hay không.

Không nên tiến hành thẩm tách cho bệnh nhân do có liên kết mạnh mẽ giữa gliclazid và protein.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: sulfonamide, dẫn xuất urea; Mã ATC: A1QB09

Gliclazid là thuốc thuộc nhóm sulfonylure dùng đường uống để hạ đường huyết, hoạt chất chống đái tháo đường này khác với các hợp chất có liên quan khác bởi một vị vòng chứa nitơ (N) với một liên kết nội vòng.

Gliclazid làm giảm mức đường huyết do kích thích tiết insulin từ các tế bào beta (β) của tiểu đảo Langerhans. Sự tăng tiết insulin và C peptid sau bữa ăn vẫn tồn tại sau 2 năm điều trị.

Cùng với các đặc tính chuyển hóa này, gliclazid có tác dụng trên mạch máu.

Tác dụng trên sự giải phóng insulin:

Trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2, gliclazid phục hồi đỉnh tiết insulin sớm trong đáp ứng với glucose và giúp tăng tiết insulin trong pha 2. Sự tăng đáng kể đáp ứng với insulin đã được quan sát thấy sau khi có kích thích gây ra bởi bữa ăn hoặc glucose.

Tính chất huyết mạch: Gliclazid làm giảm vi huyết khối bằng hai cơ chế có thể có vai trò trong biến chứng của đái tháo đường:

- Ức chế một phần sự kết tập và dính của tiểu cầu, cũng như làm giảm các dấu hiệu của sự hoạt hóa tiểu cầu (beta thromboglobulin, thromboxane B2);
- Tác dụng trên hoạt tính tiểu fibrin của nội mạc mạch máu, kèm tăng hoạt tính của t-PA.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu: Nồng độ thuốc trong huyết tương tăng dần trong 6 giờ đầu tiên, duy trì ở mức đỉnh từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 12 sau khi uống.

Sự khác biệt giữa các cá thể không đáng kể.

Gliclazid được hấp thu hoàn toàn, thức ăn không có ảnh hưởng tới tốc độ hoặc mức độ hấp thu.

Phân bố: Gliclazid gắn khoảng 95% vào protein huyết tương. Thể tích phân bố khoảng 30 lít.

Liều duy nhất hàng ngày của gliclazid duy trì được nồng độ gliclazid hữu hiệu trong huyết tương trong hơn 24 giờ.

Chuyển hóa: Gliclazid chuyển hóa chủ yếu qua gan và đào thải chủ yếu qua nước tiểu; dưới 1% dạng chum chuyển hóa được tìm thấy trong nước tiểu.

Không tìm thấy các chất chuyển hóa có hoạt tính trong huyết tương.

Thải trừ: Thời gian bán thải của gliclazid dao động từ 12 đến 20 giờ.

Tuyến tính/ Không tuyến tính: Cho tới liều 120 mg, sự tương quan giữa liều lượng với diện tích dưới đường cong biểu diễn nồng độ - thời gian (AUC) là tuyến tính.

Đối tượng đặc biệt:

Người cao tuổi: Không có thay đổi rõ rệt trên lâm sàng về các thông số được động học trên người cao tuổi.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 5 vỉ x 20 viên.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

Cơ sở sản xuất bán thành phẩm:

VALPHARMA INTERNATIONAL SPA

Via G. Morgagni, 2, 47864 - Pennabilli (RN), Italy (Ý).

Cơ sở đóng gói và xuất xưởng:

LAMP SAN PROSPERO SPA

Via Della Pace, 23/A - 41030 San Prospero (MO), Italy (Ý).